

OCE — Endodontie

Fascicule 12 · Pulpotomie · Biopulpectomie · Traitement canalaire · Retraitement

L'endodontie = traitement des pulpopathies. Dépend du degré de maturité de la dent, du type de dent (temporaire/permanente) et de la gravité. **La pose de la digue est INDISPENSABLE dans tous les cas !!!**

Vocabulaire à connaître

Les 3 types de traitements

Indications : À bien différencier

Étape	Matériel
Pulpotomie	Amputation de la pulpe camérale uniquement (la racine reste vivante)
Biopulpectomie	Ablation totale de la pulpe vivante (camérale + radiculaire)
Traitement canalaire	Ablation totale de la pulpe nécrosée (camérale + radiculaire)
Retraitement	Reprise d'un traitement endo déjà fait (infection, granulome, kyste, ramolli)

1 · Pulpotomie — plateau complet

Indications

Indications : Dents temporaires (matériau de choix CVI) et permanentes immatures

Étape	Matériel
Dents temporaires	Indication large · CONTRE-indications : résorption radiculaire, atteinte furcation, pas de reconstitution coronaire possible → avulsion
Dents permanentes immatures	Inflammation localisée · CONTRE-indication : inflammation généralisée → pulpectomie
Signaux d'avulsion	Pas de saignement (nécrose) · hémostase non obtenue (inflammation trop importante)

Plateau pulpotomie

Indications : 9 étapes — l'anesthésie est obligatoire (pulpe vivante)

Étape	Matériel
1/ Radio pré-op	Film radio / capteur · porte-film / angulateur
2/ Anesthésie	Carpule · porte-carpule · aiguille · anesthésique de contact
3/ Pose de la digue	Feuille de digue · pince Ainsworth · clamp · pince Brewer · cadre Young
4/ Éviction tissu carieux	Turbine + fraise diamantée · CA bague bleue + fraise tungstène
5/ Ouverture de la chambre pulpaire	CA + fraise boule tungstène
6/ Élimination plafond caméral + parenchyme caméral	Turbine + fraise EndoZ (bout mousse, non travaillant — élimine le plafond sans léser le plancher)
7/ Hémostase	Boulette de coton · sérum physiologique
8/ Obturation chambre pulpaire	Eugénate ou biomatériau (Biodentine, MTA)
9/ Obturation coronaire	CVI (dent temporaire) · amalgame · coiffe pédiatrique si grosse perte
10/ Radio post-op	Film radio · porte-film

2 · Biopulpectomie — plateau complet

Indications

Indications : Dent permanente mature avec pulpite ou cause prothétique/iatrogène — pulpe vivante

Étape	Matériel
Indication principale	Dent permanente mature · pulpite irréversible · cause prothétique/iatrogène
Sur dent temporaire	Peu réalisée (long, difficile chez le jeune enfant)
Sur dent immature	Tenter de conserver la vitalité avant si possible (pulpotomie)

Plateau biopulpectomie — étapes 1-5 identiques à la pulpotomie

Indications : Anesthésie obligatoire (pulpe vivante) · suite spécifique au traitement canalair

Étape	Matériel
1-5 (idem pulpotomie)	Radio · anesthésie · digue · éviction · ouverture chambre · ablation parenchyme caméral et radiculaire
Outil ouverture canaux	Turbine + fraise EndoZ · Sonde 17 (vérifie qu'il ne reste pas de plafond caméral qui obstruerait l'entrée canalair)
6/ Repérage des entrées canalaires	Sonde droite ou sonde 23
7/ Cathétérisme (pénétration initiale)	Lime K 10 ou 15 · localisateur d'apex (détermine la Longueur de Travail LT) · jauge · +/- radio avec limes en place
8/ Mise en forme canalair (alésage)	Manuel : limes K + H (racleur) en alternance ou broches · Mécanique : limes mécanisées · CA endo · forets (élargissement coronaire)
Irrigation continue	Hypochlorite de sodium (NaOCl) entre chaque lime
9/ Obturation canalair	Gutta-percha + ciment de scellement endo · fouloirs · spreaders
10/ Obturation coronaire	CVI ou composite (provisoire ou définitive)
11/ Radio post-op	Film radio · porte-film

Limes endodontiques — code couleur

Code couleur des limes (selon diamètre de la partie active) :

Rose 06 · Gris 08 · Violet 10 · Blanc 15/45/90 · Jaune 20/50/100 · Rouge 25/55/110 · Bleu 30/60/120 · Vert 35/70/130 · Noir 40/80/140.

Types de limes manuelles

Indications : Différenciées par la section de la partie active

Étape	Matériel
Section ronde · spirale à pas serrés	Racleurs (limes H/Hedström)
Section carrée · pas serrés	Limes K (limes Kerr)
Section triangulaire · spirale à pas larges	Broches

3 · Traitement canalaire (pulpe nécrosée)

Protocole proche de la biopulpectomie — 3 différences clés

Indications : Pulpe nécrosée — pas de vitalité à préserver

Étape	Matériel
Anesthésie	PAS nécessaire car la pulpe est nécrosée
Désinfection	Encore plus importante (charge bactérienne élevée)
Obturation canalaire	Peut être différée : interséance avec hydroxyde de calcium (Ca(OH) $\blacksquare$) dans le canal si écoulement purulent, saignement, lésion apicale, traitement difficile
Étapes restantes	Idem biopulpectomie (radio · digue · éviction · ouverture · cathétérisme · mise en forme · irrigation · obturation gutta + ciment)

4 · Retraitement endodontique

Indications + protocole

Indications : Reprise d'un traitement endo déjà réalisé

Étape	Matériel
Indications	Infection (granulome péri-apical, kyste) · traitement ramolli et/ou infiltré
Anesthésie	PAS nécessaire (dent non vitale)
1/ Dépose obturation coronaire ou élément prothétique	Turbine + diamantée · US + insert (si couronne)
2/ Désobturation du réseau canalaire	Solvant chimique (eucalyptol, chloroforme) · limes spécifiques · forets de désobturation
3/ Obturation du réseau canalaire	Reprise du protocole canalaire normal (mise en forme, irrigation, obturation gutta)
4/ Obturation coronaire provisoire	CVI ou ciment provisoire